内科含诊断 糖尿病 ★★★（0~4 题）

MODY “young”（β 细胞功能基因缺陷，2024） —— 发病＜ 25 岁、常染色体显性遗传；无酮症倾向、至少 5 年内不需用胰岛素

可有三多一少（多尿、多饮、多食、体重减轻）、视物模糊（屈光度改变）（2024）

	T1DM 1A（2019）	T2DM（多见）
感性认识	胰岛素绝对缺乏	胰岛素抵抗、β 细胞功能缺陷
机制	自身免疫：GADA 等	复杂
起病情况	＜ 40 岁瘦瘦多见（2014） 青少年起病急、症状明显 成年人起病慢、早期症状不明显（LADA） 临床表现变化很大	＞ 40 岁胖胖多见 起病慢
主要死因	肾病	心脑血管疾病
起病初期	多数需胰岛素、可经历蜜月期 （LADA 多数不需胰岛素）	多数不需胰岛素 （新诊断基线 HbA1c ≥ 9% 或 FPG ≥ 11.1 短期给胰岛素“911”）
C 肽 / 胰岛素（2014）	↓、曲线低平（2017）	不定、高峰延迟

并发症

感染

急性并发症（2016）“血压低而尿量多”

	DKA（2016、2019、2025）	HHS（2015）
多见于	T1DM（2014）	＞ 50 岁 T2DM
糖	血糖多 11.1~33.3、尿糖强阳性	血糖多 33.3~66.8、尿糖强阳性
酮体	尿酮强阳性、呼出气烂苹果味	尿酮阴性或弱阳性
酸中毒	有，Kussmaul 深快呼吸	多无
血浆渗透压	正常或轻度↑	＞ 320（最重要，2015）
补液（生理盐水）是关键（2012、2015、2016、2022、2023）	NS+RI →血糖降至 13.9 →加 G “先盐后糖、医生救我” 1~2h 内补 NS 1000~2000ml	NS+RI →血糖降至 16.7 →加 G“哈哈上岸要录取我” 24h 补液量可达 6000~10000ml 输 NS 后若无休克 / 渗透压＞ 350/ 血钠＞ 155 可输低渗液
胰岛素（2022、2023）	静注小剂量 RI 0.1U/kg·h	同左（0.05~0.1U/kg·h）
补钾（2017、2022）（RI 促进 K^+ 转入细胞）	K^+ ＜ 3.5 →立即补钾 K^+ 正常 + 尿量＞ 40 →立即补钾 K^+ 正常 + 尿量＜ 30 →待尿量增加后补钾“见尿补钾” K^+ ＞ 5.5 →暂缓补钾	同左
补碱（2022、2023）	pH ≤ 6.9 才补，否则 Hb 和氧亲合力↑、低钾血症（2017） 碱中毒、脑脊液酸中毒、脑水肿（慎用甘露醇）	多不补